

Desviación del tabique nasal

1. Introducción y relevancia clínica

La **desviación del tabique nasal (DTN)** es una alteración estructural en la que el tabique —la pared osteocartilaginosa que separa ambas cavidades nasales— se encuentra desplazado respecto a la línea media.

Es una condición **frecuente en la población general** (hasta 60–80%), aunque solo una minoría desarrolla síntomas clínicamente significativos.

Relevancia clínica

- Es una **causa importante de obstrucción nasal crónica** en atención primaria.
 - Puede predisponer a **rinosinusitis crónica, epistaxis recurrente, ronquido y dificultad respiratoria nocturna**.
 - Su manejo adecuado —médico o quirúrgico— es esencial para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones secundarias.
 - En EUNACOM, suele evaluarse dentro del **diagnóstico diferencial de obstrucción nasal bilateral o unilateral**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía básica del tabique nasal

El tabique está compuesto por:

1. **Porción cartilaginosa anterior (cartílago cuadrangular):** flexible, da soporte a la nariz.
2. **Porción ósea posterior:**
 - Lámina perpendicular del etmoides.
 - Vómer.
3. **Mucosa respiratoria:** recubre ambas caras del tabique.

El tabique separa las fosas nasales y contribuye al flujo aéreo laminar y la humidificación del aire inspirado.

2.2 Mecanismos de desviación

La desviación puede ser:

- **Congénita:** por desarrollo asimétrico prenatal o trauma del parto.
 - **Adquirida:** secundaria a traumatismo nasal (deportes, accidentes), fracturas, cirugía previa o crecimiento desbalanceado del tabique y el esqueleto facial.
-

2.3 Fisiopatología del compromiso funcional

Cuando la desviación es significativa, puede producir:

- **Obstrucción nasal unilateral o bilateral** (según localización).
 - **Alteración del flujo aéreo**, con turbulencia y sequedad local → epistaxis o costras.
 - **Compromiso del drenaje sinusal** → predisposición a sinusitis crónica.
 - **Compensación contralateral:** hipertrofia del cornete inferior del lado opuesto.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

Síntoma	Descripción
Obstrucción nasal	Principal motivo de consulta; suele ser unilateral y persistente.
Epistaxis recurrente	Por resequedad y fragilidad de la mucosa.

Rinorrea o congestión crónica Por alteración del drenaje sinusal.

Ronquido y respiración oral Por obstrucción mantenida.

Cefalea o dolor facial Secundario a sinusitis asociada.

3.2 Signos al examen físico

Rinoscopía anterior:

- Tabique desviado hacia un lado, con posible espolón o cresta ósea.
- Mucosa normal o con costras y áreas de sangrado.
- Hipertrofia compensatoria del cornete inferior contralateral.

Rinoscopía posterior (si disponible):

- Desviaciones posteriores o contacto con pared lateral nasal.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Rinitis alérgica	Obstrucción variable, estacional, rinorrea acuosa, prurito.
Pólipos nasales	Masa blanda, translúcida, móvil.
Hipertrofia de cornetes	Bilateral, sin desviación tabique.

Tumores nasales Obstrucción unilateral, epistaxis frecuente, masa firme.

Rinosinusitis crónica Congestión + secreción purulenta prolongada.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

El diagnóstico de desviación septal es **principalmente clínico**, basado en la anamnesis y el examen físico con **rinoscopia anterior**.

En APS, es importante reconocer la obstrucción persistente y descartar causas inflamatorias o tumorales.

4.2 Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Endoscopia nasal	Confirma grado y localización de la desviación, visualiza espolones posteriores.
TAC de senos paranasales	En pacientes con sinusitis crónica o sospecha de alteraciones estructurales asociadas.
Rinomanometría	Mide resistencia al flujo aéreo nasal; uso limitado fuera del ámbito especializado.

4.3 Criterios diagnósticos (clínicos)

1. **Obstrucción nasal persistente unilateral o bilateral.**
2. **Desviación visible del tabique en rinoscopia.**

3. **Exclusión de causas inflamatorias (rinitis, pólipos).**
 4. **Mejoría insuficiente con tratamiento médico (lavados, corticoides tópicos).**
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento depende de la severidad de los síntomas y del impacto funcional o estético.

5.1 Tratamiento médico

Indicado en desviaciones leves o sintomáticas por inflamación asociada.

Objetivos: disminuir edema y mejorar flujo nasal.

Medidas:

- **Lavados nasales con solución salina hipertónica (0,9–3%),** 2 veces al día.
- **Corticoides nasales tópicos** (budesonida o mometasona), especialmente si hay rinitis alérgica asociada.
- **Antihistamínicos orales** en caso de componente alérgico.
- **Evitar descongestionantes tópicos crónicos** (riesgo de rinitis medicamentosa).

Nota MINSAL: El manejo médico no corrige la desviación estructural, pero puede aliviar síntomas leves.

5.2 Tratamiento quirúrgico (Septoplastía)

Indicaciones

- Obstrucción nasal persistente que no responde a tratamiento médico.
- Sinusitis crónica por alteración del drenaje.
- Epistaxis recurrente o costras por turbulencia.
- Alteración del sueño o ronquido significativo.

- Desviaciones traumáticas o con deformidad estética.

Procedimiento

- **Septoplastía endonasal funcional:**
 - Reposición o resección del cartílago y hueso desviados.
 - Preserva soporte estructural nasal.
- Puede combinarse con **turbinoplastía** si hay hipertrofia de cornetes.

Postoperatorio

- Taponamiento nasal por 24–48 horas.
- Lavados salinos y pomadas antibióticas locales.
- Evitar sonarse o esfuerzos físicos durante 1 semana.
- Control ORL a los 7–10 días.

5.3 Complicaciones quirúrgicas

Complicación	Descripción
Hemorragia postoperatoria	Frecuente; control con compresión o taponamiento.
Hematoma septal	Dolor, obstrucción, edema; requiere drenaje urgente.
Perforación septal	Por resección excesiva o cauterización bilateral.
Sinequias (adherencias)	Evitables con correcto manejo postoperatorio.

Deformidad nasal (saddle nose)

Por resección estructural excesiva.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones no tratadas

- **Obstrucción respiratoria crónica.**
- **Sinusitis recurrente o crónica.**
- **Epistaxis o costras persistentes.**
- **Alteraciones del sueño y ronquido.**
- **Deformidad estética externa (nariz desviada).**

6.2 Pronóstico

- **Excelente con corrección quirúrgica adecuada.**
 - **Reurrencia de desviación es baja, pero posible en traumas posteriores o cicatrización asimétrica.**
 - **La cirugía no corrige rinitis alérgica subyacente, por lo que puede requerir tratamiento médico complementario.**
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **La desviación del tabique nasal es la causa estructural más común de obstrucción nasal crónica.**
2. **El diagnóstico es clínico, basado en rinoscopía y síntomas persistentes.**
3. **El tratamiento médico alivia, pero no corrige la desviación.**

4. **Septoplastía funcional** es el tratamiento definitivo en casos sintomáticos.
 5. **Evitar cauterizar ambos lados del tabique** (riesgo de perforación).
 6. En presencia de **rinitis alérgica concomitante**, siempre mantener **corticoides tópicos**.
 7. En **niños pequeños**, se reserva cirugía para casos severos por riesgo de afectar crecimiento facial.
-

Errores comunes

- Indicar antibióticos o descongestionantes sin causa infecciosa.
 - No diferenciar obstrucción estructural de rinitis inflamatoria.
 - No derivar a ORL pese a obstrucción persistente.
 - Olvidar tratar rinitis concomitante después de cirugía.
 - Realizar cauterización bilateral o manipulación excesiva del tabique.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **desviación del tabique nasal** es una causa estructural de **obstrucción nasal persistente**.
2. Su diagnóstico es **clínico**, mediante **rinoscopia o endoscopia**.
3. El **tratamiento médico** mejora síntomas leves, pero **no corrige la deformidad**.
4. La **septoplastía** es el tratamiento definitivo en desviaciones sintomáticas.
5. Siempre descartar **rinitis o pólipos concomitantes**.
6. Complicaciones quirúrgicas son poco frecuentes y prevenibles.
7. En **EUNACOM**, recordar que la **epistaxis recurrente unilateral** puede ser signo de desviación o lesión vascular local.